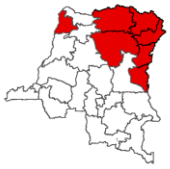
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°150 /MVE-BDBV/11/10/2026

Date du rapport : 12 octobre 2026 Date de publication : 13 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- **L'activité diagnostique demeure soutenue**, avec 423 échantillons analysés, contre 445 la veille (−4,9 %) et 331 le 04 octobre (+27,8 %). Les décès dans les CTE restent stables à **8** par rapport à la veille et diminuent par rapport au 04 octobre (11 ; −27,3 %).
- **Toutefois, 88 nouveaux cas confirmés** ont été notifiés soit Ituri (56), Nord-Kivu (28) et Haut-Uélé (4) contre 64 la veille (+37,5 %) et 59 le **04 octobre (+49,2 %). Les décès communautaires passent de 13 à 37 par rapport à la veille et de 23 à 37 par rapport au 04 octobre. La positivité atteint 20,8 %, contre respectivement 14,4 % et 17,8 %, appelant à renforcer la détection précoce et les interventions communautaires.**

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
9066	4 381	48,3 %	895	2 389	79,5%

Provinces touchées et zones de santé touchées

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi

65 Zones de santé touchées sur 167 (38,9%)

La riposte contre la maladie à virus Ebola (MVE), souche Bundibugyo, continue d'enregistrer des résultats encourageants en matière de prise en charge des patients. Au cours des dernières 24 heures, 33 patients ont été déclarés guéris, après deux tests de contrôle négatifs, dont 16 en Ituri, 10 au Nord-Kivu, 5 au Haut-Uélé et 2 dans la Tshopo. Par ailleurs, 8 décès ont été enregistrés dans les centres de traitement Ebola (CTE), un chiffre stable par rapport à la veille, mais en diminution de 27,3 % par rapport au 04 octobre 2026 (11 décès).

Toutefois, la transmission communautaire demeure préoccupante, avec 88 nouveaux cas confirmés, répartis entre l'Ituri (56), le Nord-Kivu (28) et le Haut-Uélé (4), contre 64 cas la veille, soit une augmentation de 37,5 %, et 59 cas le 04 octobre, soit une hausse de 49,2 %. La province de la Tshopo n'a notifié aucun nouveau cas, constituant un signal encourageant à consolider par le maintien d'une surveillance renforcée.

En matière de mortalité, 37 décès communautaires ont été rapportés, contre 13 la veille et 23 le 04 octobre, soit une augmentation respective de 184,6 % et de 60,9 %. Le total des décès confirmés notifiés au cours de la journée s'élève ainsi à 45 décès, dont 37 en communauté et 8 dans les CTE. Cette situation appelle une intensification de la détection précoce, du référencement rapide des cas suspects et de l'engagement communautaire, particulièrement dans les zones de transmission active.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC totalise 9 066 cas confirmés et 4 381 décès, soit une létalité cumulée de 48,3 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 73,8 % des cas cumulés et 63,6 % des nouveaux cas. Au total, 65 zones de santé sur 167 (38,9 %) ont été affectées dans sept provinces 12 **ZS ont atteint au moins 42 jours sans nouveau cas confirmé et** 3 ZS se retrouvent entre 22 et 42 jours sans nouveau cas confirmé. Cependant, 269 PPL ont été touchées par la MVE BDB_17. La répartition des PPL sont répartis de la manière suivante : Bas-Uele (1), Haut-Uele (31), Ituri (180), Nord-Kivu (45) et Tshopo (12).

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CAS ET DÉCÈS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET SITUATION DES ZONES DE SANTÉ, AU 11 OCTOBRE 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées*
Ituri	**56**	6 695	3 099	46,3 %	28/36 (77,8 %)	25/36 (69,4 %)
Nord-Kivu	**28**	1 911	1 092	57,1 %	17/34 (50,0 %)	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	**4**	383	162	42,3 %	7/13 (53,8 %)	7/13 (53,8 %)
Tshopo	**0**	59	22	37,3 %	7/23 (30,4 %)	5/23 (21,7 %)
Sud-Kivu	**0**	3	1	33,3 %	1/34 (2,9 %)	0/34 (0,0 %)
Bas-Uélé	**0**	13	4	30,8 %	4/11 (36,4 %)	4/11 (36,4 %)
Sud-Ubangi	**0**	2	1	50,0 %	1/16 (6,3 %)	1/16 (6,3 %)
Total	**88**	**9 066**	**4 381**	**48,3 %**	**65/167 (38,9 %)**	**57/167 (34,1 %)**

Au 11 octobre 2026, **9 066 cas confirmés et 4 381 décès** sont cumulés, soit une létalité de **48,3 %**. L'Ituri demeure l'épicentre, avec **73,8 % des cas cumulés** et 56 des 88 nouveaux cas. Le Nord-Kivu présente la létalité la plus élevée (**57,1 %**), appelant un renforcement de la détection précoce et de l'accès rapide aux soins.

Aucun nouveau cas n'a été notifié dans quatre provinces : Tshopo, Sud-Kivu, Bas-Uélé et Sud-Ubangi. Ce constat encourageant nécessite le maintien de la vigilance. Au total, **65 zones de santé ont été historiquement touchées** ; les **57 actuellement affectées** correspondent à la situation du **11 octobre 2026**.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 11 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6695**	**3099**	**46,3%**	**56**	**22**	**3**	**25**
Adja	12	1	8,3%				0
Aru	9	6	66,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	214	47	22,0%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1832	612	33,4%	20	7	1	8
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	11	7	63,6%	2	2	0	2
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	179	107	59,8%	1	0	0	0
Lita	302	154	51,0%	4	3	0	3
Logo	14	7	50,0%				0
Lolwa	35	9	25,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	43	18	41,9%	2	1	0	1
Mandima	258	132	51,2%	18	7	1	8
Mangala	370	161	43,5%	1	0	1	1
Mongbwalu	712	341	47,9%				0
Nia-Nia	327	183	56,0%	3	2	0	2
Nizi	813	290	35,7%	4	0	0	0
Nyankunde	133	39	29,3%				0

Rimba	18	5	27,8%				0
Rwampara	1132	393	34,7%	1	0	0	0
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	**1911**	**1092**	**57,1%**	**28**	**15**	**2**	**17**
Beni	458	309	67,5%	16	10	1	11
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	297	185	62,3%				0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	70	26	37,1%	2	0	0	0
Katwa	628	383	61,0%	5	4	0	4
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	37	20	54,1%				0
Lubero	28	12	42,9%				0
Mabalako	63	22	34,9%	1	0	1	1
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	15	5	33,3%	1	0	0	0
Masereka	36	12	33,3%				0
Musienene	143	69	48,3%				0
Mutwanga	23	4	17,4%				0
Oicha	42	20	47,6%	3	1	0	1
Vuhovi	39	13	33,3%				0
Haut-Uélé	**383**	**162**	**42,3%**	**4**	**0**	**3**	**3**
Boma Mangbetu	44	19	43,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	46	45,1%		0	2	2
Pawa	100	48	48,0%	2	0	1	1
Rungu	5	2	40,0%	1	0	0	0
Wamba	128	45	35,2%	1	0	0	0
Tshopo	**59**	**22**	**37,3%**	0	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	6	1	16,7%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	32	12	37,5%				0
Mangobo	10	7	70,0%				0
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	**9066**	**4381**	**48,3%**	**88**	**37**	**8**	**45**

Aucun nouveau cas ni décès n'a été notifié dans la Tshopo, le Sud-Kivu, le Bas-Uélé et le Sud-Ubangi, tandis que le Haut-Uélé ne rapporte aucun décès communautaire.

Les nouvelles notifications restent concentrées en **Ituri et au Nord-Kivu, avec 84 des 88 cas (95,5 %)**. Bunia (20 cas), Mandima (18) et Beni (16) regroupent **61,4 % des nouveaux cas**, justifiant une intensification ciblée des interventions.

Les **37 décès communautaires représentent 82,2 % des 45 décès du jour**, ce qui appelle à renforcer la détection précoce, le référencement rapide, les EDS et l'engagement communautaire. La létalité cumulée demeure particulièrement élevée au Nord-Kivu (**57,1 %**)

Tableau 3. Situation des alertes notifiées 11 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	90	4	94	7	4	83	0	11	5
Bas Uélé	83	2	85	12	2	71	0	14	0
Ituri	1 029	63	1092	96	63	933	0	159	81
Nord-Kivu	998	43	1041	107	41	891	2	148	57
Sud Ubangi	80	2	82	0	0	80	2	0	0
Tshopo	109	0	109	2	0	107	0	2	0
Total Général	**2 389**	**114**	**2 503**	**224**	**110**	**2 165**	**4**	**334**	**143**

La vérification des alertes et l'investigation des suspects affichent une couverture complète : les **2 503 alertes reçues ont toutes été vérifiées**, et les **334 suspects identifiés (13,3 %) ont tous été investigués**. Les totaux du tableau sont cohérents.

L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent **85,2 % des alertes** et **91,9 % des suspects**, confirmant leur poids dans l'activité de surveillance. Parmi les **114 alertes de décès**, 110 ont été validées comme cas suspects (**96,5 %**), soulignant l'importance de la surveillance communautaire des décès ; cette validation ne constitue toutefois pas une confirmation biologique de MVE.

Le transfert vers les CT/CTE reste le principal point d'attention : 143 suspects sur 334 ont été transférés (**42,8 %**), dont 81 en Ituri et 57 au Nord-Kivu. Aucun transfert n'est rapporté au Bas-Uélé malgré 14 suspects investigués. Il convient de documenter la situation des suspects non transférés et de lever les obstacles au référencement, notamment pour les suspects vivants nécessitant une prise en charge.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

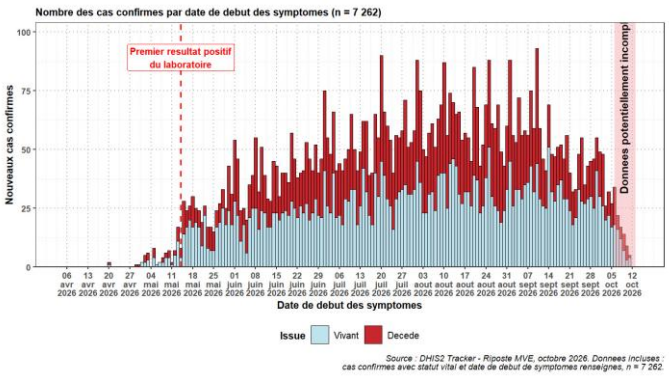
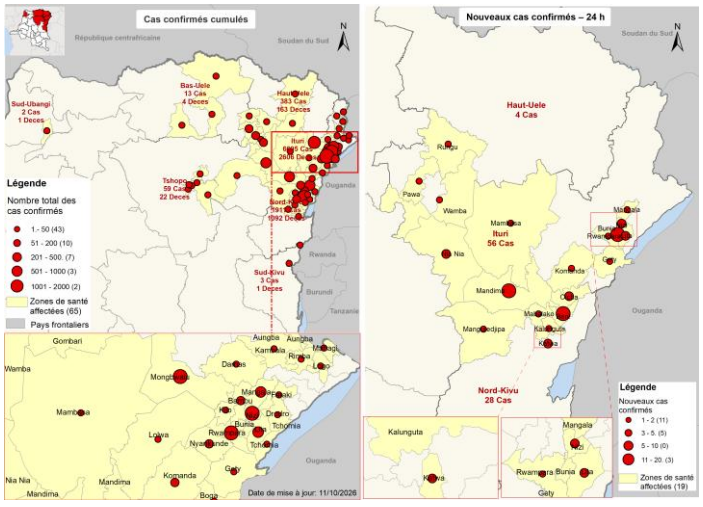


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1.COORDINATION

1.1. Principales Actions

La coordination poursuit l'appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques. Les principales actions comprennent :

- **La tenue de réunions de coordination** pour examiner la situation épidémiologique, suivre les interventions, identifier les difficultés opérationnelles et convenir des mesures correctrices avec les équipes provinciales et les partenaires.
- **Le déploiement des équipes à Mandima et dans les autres foyers actifs**, afin de renforcer les interventions de proximité et d'appuyer les équipes locales.
- **Le renforcement de la concertation entre les piliers techniques et les partenaires**, pour adapter les interventions aux besoins prioritaires et faciliter la mobilisation des ressources.

1.2.Défi majeur

Assurer une réponse rapide, intégrée et continue dans les foyers actifs, notamment à Mandima, malgré les contraintes de sécurité, d'accès et d'adhésion communautaire.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

En date du 11 octobre 2026, 2 503 alertes ont été rapportées dans six provinces (Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Tshopo). Ces alertes ont toutes été vérifiées (100 %), dont 334 (13,3 %) validées comme cas suspects. Les 334 cas suspects ont tous été investigués (100 %). Parmi eux, 143 (42,8 %) ont été transférés vers les CT/CTE.

Parmi les 27 043 contacts en cours de suivi dans les provinces ayant transmis leurs données, 21 512 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de 79,5 %, en baisse par rapport à la veille (81,0 %) et toujours inférieure au seuil requis de 95,0 %. Cette proportion était de 100,0 % (44/44) au Sud-Ubangi, de 100,0 % (321/321) au Bas-Uélé, de 89,1 % (1 558/1 749) au Haut-Uélé, de 81,9 % (6 746/8 236) en Ituri, de 78,9 % (276/350) à la Tshopo et de 76,9 % (12 567/16 343) au Nord-Kivu.

2.1.2. Défi majeur

Améliorer la couverture quotidienne du suivi des contacts, particulièrement au Nord-Kivu et en Ituri, afin de retrouver les **5 531 contacts non vus (20,5 %)** et d'atteindre le seuil requis de **95 %**.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Dix (10) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC le 11 octobre : six (6) en Ituri, trois (3) au Bas-Uélé et une (1) au Haut-Uélé ; aucune au Nord-Kivu ni à la Tshopo. En Ituri, sur les cinq (5) alertes vivantes validées, une seule a été référée au CTE de Komanda (PoC Base Yedi) et s'est révélée positive, soit le 66e cas confirmé détecté aux PoC ; les quatre autres ont refusé leur transfert. Au Bas-Uélé, un corps sans vie a été intercepté et swabé au PoC Bale, et au Haut-Uélé une alerte du PoC Bombombi a été invalidée après résultat.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 11 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	98,3% (60/61)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	98,0% (98/100)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	136 295	86 153	19 203	241 651
% des voyageurs screenés	98,1%	97,6%	98,1%	97,9%

% des voyageurs ayant lavé les mains	97,9%	97,6%	98,1%	97,8%
% des voyageurs sensibilisés	99,5%	97,6%	100,0%	98,9%
Nombre d'alertes notifiées	6	0	0	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	5	0	0	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	20,0%	NA	NA	20,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	NA	NA	100,0%

2.2.2. Défis

Renforcer l'adhésion au référencement et assurer le transfert rapide des alertes vivantes validées aux PoE/PoC vers les CT/CTE. En Ituri, **quatre des cinq alertes vivantes validées ont refusé leur transfert (80 %)**, soulignant la nécessité de renforcer la sensibilisation, l'implication des leaders communautaires et la disponibilité des moyens de transport pour faciliter l'accès aux soins et limiter le risque de transmission.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 56 nouveaux résultats positifs** (34 vivants et 22 décès) sur 239 échantillons reçus et analysés **(positivité : 23,4 %) ;**
- **Nord-Kivu : 28 nouveaux résultats positifs** (13 vivants et 15 décès) sur 132échantillons reçus et analysés **(positivité : 21,2%) ;**
- **Haut-Uélé : 4 nouveaux résultats positifs (**4 vivants) **sur 36 échantillons reçus et analysés (positivité : 11,1%) ;**
- **Tshopo : 5 nouveaux** échantillons reçus **et analysés (tous vivants)** tous sont révélés négatifs ;
- **Bas Uélé : 11 nouveaux** échantillons reçus et analysés (**tous vivant)** tous sont révélés négatifs.

2.3.2. Défi majeur

Maintenir un diagnostic rapide et fiable dans toutes les provinces, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, qui concentrent **84 des 88 résultats positifs (95,5 %)**. La confirmation de **37 cas sur des prélèvements post-mortem** souligne également la nécessité de renforcer le prélèvement précoce chez les suspects vivants, l'acheminement des échantillons et la transmission rapide des résultats pour orienter la prise en charge et les interventions autour des cas.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri :** 8 rings ont été ouverts sur 22 (36,4 %), 21 ménages décontaminés sur 25 (84,0 %) et 3 FOSA décontaminées sur 3 (100 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 68 alertes EDS (dont 15 reports de la veille), 55 EDS ont été réalisés (80,9 %) et 56 corps swabés ;
- **Nord-Kivu :** 23 rings ont été ouverts sur 32 (71,9 %), avec un gap à Katwa et Mabalako, 26 ESS décontaminées sur 32 (81,3 %) et 14 ménages sur 30 (46,7 %), aucun des ménages décontaminés n'ayant été doté en kits ; 4 évaluations PCI (score card) ont été réalisées dans 4 ESS avec un score moyen de 30,8 %, 695 prestataires ont été briefés et aucun PPL n'a été infecté parmi les 25 cas confirmés du 10 octobre (0/25). Sur 54 alertes de décès et 48 reports de la veille, 57 EDS ont été réalisés et 54 corps swabés sans échec, avec 45 reports au jour suivant ;

- **Haut-Uélé :** 2 ménages ont été décontaminés à Isiro (2/2 ; 100 %), 2 ESS de Wamba ont été suivies avec le briefing de 5 infirmiers sur le port et le retrait des EPI, et 8 PPL ont été briefés (5 à Wamba et 3 à Boma Mangbetu). Sur 9 alertes EDS, 8 EDS ont été réalisés (88,9 %) et 5 corps swabés, sans échec, avec un refus d'EDS à Isiro ;
- **Tshopo :** 9 ESS sur 9 ont été suivies et 116 prestataires briefés ; le CM Vita Nova, le ménage du 55e cas, les CUKis et l'HGR Makiso-Kisangani (58e cas) ont été décontaminés. Le cumul atteint 41 rings ouverts sur 41 (100 %) et 35 ménages décontaminés sur 44 (79,5 %) ; sur 2 alertes EDS, 1 corps a été swabé.

2.4.2. Défis

Combler les gaps de couverture des rings, de décontamination et de dotation en kits, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, tout en améliorant les pratiques PCI dans les structures de soins, au regard du **score moyen de 30,8 %** observé dans les quatre ESS évaluées au Nord-Kivu. La réalisation rapide des EDS reste également prioritaire pour résorber les **45 reports au Nord-Kivu** et lever les refus communautaires, notamment à Isiro, afin de réduire les risques de transmission lors des soins et des funérailles.

2.4.3. Prise en charge holistique

2.4.4. Principales actions

- **En Ituri,**76 nouvelles admissions, (dont 10 en phase avancée), ont été enregistrées contre 71 sorties, dont 16 guérisons. Ainsi, 337 patients, soit un taux d'occupation de 33,2 %, dont 41 malades critiques ; 21 patients ont été évacués par ambulance et 337 patients sur 347 (97,1 %) ont reçu un repas chaud. Le cumul des guéris de la province atteint 1 895) ;
- **Au Nord-Kivu,** 79 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 109 sorties, dont 10 guérisons. Ainsi, 471 patients dont 67 enfants de moins de 5 ans) sont hospitalisés : 330 dans les CTE/CT pour 374 lits, soit un taux d'occupation de 88,2 %, et 107 (22,7 %) dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT ; 5 malades sont en état critique (CTE de Kitatumba et CT d'Oicha) et les 20 courses d'ambulance ont toutes abouti ;
- **Au Haut-Uélé,** 7 nouvelles admissions (1 confirmé à Isiro et 6 suspects à Pawa et Wamba) ont été enregistrées contre 5 guérisons à Boma Mangbetu. Ainsi, 45 patients, soit un taux d'occupation de 32,6 %, dont 2 malades confirmés sévères ou critiques à Pawa et à Wamba ; 55 patients, 67 accompagnants et 70 PPL ont reçu des repas chauds et 6 patients ont été transportés par ambulance ;
- **À la Tshopo,** 11 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 2 sorties, tous des guérisons. Ainsi, 15 patients sont hospitalisés pour 36 lits, soit un taux d'occupation de 41,7 %, sans malade en état sévère ; le 54e cas confirmé n'a toujours pas été transféré au CTE. Depuis le début, 443 personnes ont reçu le traitement expérimental, dont 41 cas confirmés, et 402 la prophylaxie post-exposition ;
- **Au Bas-Uélé,** 12 nouveaux cas suspects ont été admis dans les centres de transit, sans aucune sortie ni nouvel admis confirmé ; la prise en charge post-exposition s'est poursuivie à Limba (ZS de Viadana) et l'enfant confirmé de 21 mois isolé à Dingila reste suivi.

2.4.5. Défis

Garantir une prise en charge précoce, complète et adaptée aux patients sévères ou critiques, tout en renforçant les capacités d'accueil au Nord-Kivu, où l'occupation des CTE/CT atteint **88,2 %** et **107 patients sont hospitalisés dans des ESS hors CTE/CT**.

2.5. Vaccination

2.5.1. Principales actions

- **Au Haut-Uélé,** le cumul atteint 399 PPL vaccinés sur 858 préenregistrés (46,5 %), dont 210 femmes et 189 hommes ; à Isiro, 220 personnes sur 313 pré-listées ont été vaccinées sur le site de l'HGR (70,3 %) ;
- **En Ituri,** la collecte des données de l'étude sur l'impact de l'épidémie de MVE sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive s'est poursuivie dans les ZS de Mongbwalu, Bunia, Rwampara, Tchomia et Nyarambe, de même que les enquêtes qualitatives et opérationnelles et les essais cliniques Partners, Oracle et EBO-PEP.

2.5.2. Défis

Améliorer la couverture vaccinale des PPL préenregistrés au Haut-Uélé, où **459 personnes sur 858 restent à vacciner (53,5 %)**, en renforçant leur mobilisation et l'accès aux sites de vaccination.

2.6. Continuité des Soins

2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo,** l'évaluation des Cliniques des Anges de Kisangani (CAKIS) a montré une zone de triage effective, un incinérateur opérationnel et une utilisation systématique du partogramme, mais seulement 6 agents vaccinés contre la MVE sur 21 (28,6 %) ; le plan de redressement du CS RTNC a été élaboré, et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis ;
- **Au Nord-Kivu,** l'encodage des évaluations de la continuité des services de santé essentiels dans les ESS de la ZS de Butembo s'est poursuivi ;
- **Au Bas-Uélé,** aucune donnée n'a été transmise par le pilier continuité des soins au cours des dernières 24 heures**.**

2.6.2. Défi majeur

Garantir la continuité et la sécurité des services de santé essentiels en assurant la mise en œuvre des mesures correctrices dans les ESS évaluées, notamment au CS RTNC, et en améliorant la couverture vaccinale des agents éligibles aux CAKIS, où **15 agents sur 21 restent non vaccinés (71,4 %)**. Il convient également de consolider le suivi des guéris présentant des comorbidités et d'assurer la transmission régulière des données, particulièrement au Bas-Uélé, pour identifier les interruptions de services et orienter les actions.

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri,** 24 812 visites à domicile ont touché 83 512 personnes ; 1 002 causeries éducatives ont réuni 15 563 personnes, 8 sensibilisations de masse 2 090 personnes, 4 débats communautaires 158 personnes et 8 plaidoyers 17 autorités et leaders ; 38 spots ont été diffusés sur 36 stations de radio et 9 émissions organisées. Au total, 460 alertes communautaires, dont 129 décès, ont été notifiées ; 70 feedbacks sur 85 (82,4 %) et 8 incidents sur 11 (72,7 %) ont été résolus dans les 48 heures, 859 contacts ont été pré-listés autour de 19 cas confirmés et un survivant de la MVE a été réinséré au village Lumumba (AS de Mangusu, ZS de Komanda), avec la sensibilisation des leaders contre la stigmatisation. La complétude des rapports CREC n'est que de 42,9 % (12/28 ZS) ;
- **Au Bas-Uélé,** une séance de sensibilisation de masse a touché 839 personnes au marché et dans 8 églises de la ZS de Dakwa, une émission interactive a été diffusée sur la radio communautaire Rubi de Buta, un guéri a sensibilisé 53 personnes à Viadana et 11 membres d'une famille de Dakwa ont accepté l'isolement et le prélèvement d'un cas suspect ; les 5 alertes communautaires notifiées ont toutes été traitées ;
- **À la Tshopo,** 26 séances de sensibilisation de masse ont touché 31 861 personnes, dont 4 219 enfants, dans 26 églises, et une causerie éducative 30 personnes à Kabondo ; 20 alertes communautaires ont été notifiées et toutes traitées, les 2 feedbacks reçus ont été résolus (100 %), dont une rumeur sur un traitement d'Ebola par les fleurs de palmier, et la CREC a appuyé le suivi de 12 contacts et le listage de 6 nouveaux contacts à Kabondo ;
- **Au Haut-Uélé,** 5 séances de sensibilisation de masse ont touché 5 060 fidèles dans les églises de Wamba et d'Isiro et 2 causeries éducatives 32 conducteurs de taxi-motos à Wamba, soit 5 092 personnes ; 5 alertes communautaires, dont 3 décès, ont été notifiées à Wamba et à Isiro, les 3 feedbacks reçus ont été résolus (100 %) et 31 membres de la famille d'un décès suspect ont été sensibilisés au suivi des contacts, à la décontamination et à l'EDS à Isiro, tandis que le Vice-Gouverneur a pris part à l'intensification de la sensibilisation à Wamba ;
- **Au Nord-Kivu,** 6 644 visites à domicile ont touché 19 419 personnes, 185 causeries éducatives 3 673 personnes, 45 communications de masse 7 967 personnes et 1 briefing 26 journalistes ; 266 alertes communautaires ont été notifiées sur 650 attendues (40,9 %), 14 feedbacks sur 17 (82,4 %) ont été résolus dans les 48 heures, les acteurs CREC ont été

déployés dans les cultes et messes du dimanche, 215 parents ont été sensibilisés à l'Institut Mangina et 55 contacts ont été listés avec l'appui de la CREC à Lubero et à Manguredjipa.

2.7.2 Défi majeur

Forte mobilisation communautaire en une adhésion durable à l'alerte précoce, au suivi des contacts, au référencement et aux EDS, en renforçant la gestion des rumeurs, des résistances et de la stigmatisation.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **Ituri,** 17 derniers cas confirmés sur 30 (56,7 %), 83 confirmés en cours de suivi sur 101 (82,2 %), 26 nouveaux suspects sur 53 (49,1 %) et 135 suspects en cours de suivi sur 160 (84,4 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 252 accompagnants et 72 PPL, suivi 11 guéris sur 16 (68,8 %) en communauté et 13 enfants sur 13 en crèche, accompagné 7 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 12, réinséré 5 guéris sur 14 et annoncé 31 résultats, dont 17 positifs ; 41 enfants sont suivis ;
- **Au Nord-Kivu**, 23 derniers cas confirmés sur 25 (92,0 %), 212 confirmés en cours de suivi, 191 nouveaux suspects et 376 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les 9 ZS ayant notifié (100 %) ; les équipes ont accompagné 98 ménages et 25 ménages d'enfants séparés et orphelins (100 %), soutenu 89 PPL, suivi 35 enfants en communauté et 6 en crèche, réinséré 10 guéris, suivi 12 guéris en communauté et annoncé 122 résultats, dont 25 positifs ; 384 personnes ont bénéficié de la psychoéducation avec l'appui de l'UNICEF
- **À la Tshopo**, 7 confirmés en cours de suivi sur 7 (100 %), 1 nouveau suspect et 3 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 242 personnes ont bénéficié de la psychoéducation, 3 résultats, dont 2 positifs, ont été annoncés et 25 APS de Bafwasende ont été formés ;
- **Au Haut-Uélé,** 19 confirmés en cours de suivi, 4 nouveaux suspects et 30 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 33 accompagnants, 64 PPL, 11 enfants séparés en communauté et 9 membres de ménages, appuyé 6 EDS et annoncé 18 résultats, dont 6 positifs ; au Bas-Uélé, aucune intervention SMSPS n'a été rapportée au cours des dernières 24 heures.

2.8.2. Défis

Assurer une couverture équitable et continue du soutien psychosocial, particulièrement en Ituri, où seuls **56,7 % des derniers cas confirmés** et **49,1 % des nouveaux suspects** ont bénéficié d'interventions SMSPS.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions.

L'appui logistique vise à assurer la mobilité des équipes de terrain dans les provinces touchées, en facilitant la disponibilité des moyens de transport, du carburant et la maintenance des véhicules, afin de soutenir les investigations, le suivi des contacts, les interventions communautaires et l'acheminement des intrants.

Au Nord-Kivu, les préparatifs logistiques doivent permettre l'ouverture du CTE de Musienene, projetée pour le 15 octobre 2026, notamment par la mise à disposition des équipements, des consommables et des services essentiels à son fonctionnement.

2.9.2. Défi majeur

Garantir la disponibilité continue des moyens de mobilité et des intrants dans les foyers actifs, tout en assurant la préparation opérationnelle du CTE de Musienene dans le délai prévu.

2.10. Sécurité

2.10.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, les équipes ont été escortées pour l'enterrement d'un cas confirmé au cimetière de Bundji, la décontamination d'un ménage de l'AS de Kasanga et du dispensaire Arche (AS de Ngongolyo), le swab d'un corps sans vie à la morgue Horizon et l'état des lieux de l'AS de Kambuli (Katwa) avec le partenaire FHI 360 ; une séance de démonstration des pratiques d'EDS a également été organisée à Kambuli avec l'équipe de mitigation des risques

2.10.2. Défi majeur

Garantir un accès sécurisé et continu des équipes aux zones d'intervention, particulièrement à Katwa, tout en renforçant l'acceptation communautaire des EDS, des prélèvements post-mortem et des décontaminations.

2.11. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.11.1. Principales actions

- **À la Tshopo,** 85 acteurs de six piliers de la riposte (52 femmes et 33 hommes) ont été briefés sur la PSEAH avec l'appui de l'OMS et ont signé le code de bonne conduite ; 641 personnes ont été sensibilisées à Kabondo, Makiso-Kisangani et Mangobo ;
- **Au Nord-Kivu,** 26 prestataires du pilier santé mentale (18 hommes et 8 femmes) ont été briefés sur la PSEAH à Butembo et 125 personnes ont été sensibilisées sur la PSEA et les numéros de signalement 151 et 495555 à Mabalako (15) et dans les AS de Vungi et Taraja à Katwa (110).

2.11.2. Défis

Au niveau national, seules 2 DPS sur 7 (28,6 %) ont rapporté leurs activités PSEA (Nord-Kivu et Tshopo) ; à la Tshopo, la couverture reste faible, avec 7 ZS sur 23 couvertes et 85 personnels formés sur 270 (31,5 %), tandis que la proportion de ZS connaissant le mécanisme de signalement demeure faible en Ituri (36,1 % ; 13/36), au Nord-Kivu (17,6 % ; 6/34) et au Haut-Uélé (46,2 % ; 6/13).

2.12. Gestion des bases des données

2.12.1. Principales actions :

- La centralisation et la mise à jour des données transmises par les provinces et les piliers techniques ;
- La vérification de la complétude, la recherche des doublons et la correction des incohérences entre les données de surveillance, de laboratoire et de prise en charge ;
- La réconciliation des listes de cas, de contacts, de décès et de guéris, notamment la ventilation des décès par zone de santé ;
- L'appui aux équipes provinciales pour l'encodage et la transmission régulière des données, ainsi que la production des tableaux de suivi et des indicateurs du SitRep.

2.12.2. 2.12.2. Défi majeur

Disposer, dans les délais requis, d'une base consolidée, complète et cohérente permettant de suivre les chaînes de transmission et d'orienter les interventions.

MESSAGES CLES

- Les acquis de la surveillance sont maintenus, avec 100 % des alertes vérifiées et 100 % des cas suspects investigués au cours des dernières 24 heures. Aucun nouveau cas n'a été notifié à la Tshopo, où les notifications restent sporadiques ; ce signal encourageant nécessite le maintien de la vigilance.
- La transmission communautaire demeure active en Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé. Le suivi des contacts atteint 79,5 %, contre 81,0 % la veille, soit une baisse de 1,5 point, et reste inférieur au seuil requis de 95 %.
- Retrouver les contacts non vus et accélérer le référencement des suspects constituent des priorités pour limiter les chaînes de transmission.
- Consolider ces acquis exige une réponse intégrée dans les foyers actifs : renforcer la surveillance de proximité, la PCI, les EDS et la CREC, tout en assurant un accès précoce à des soins de qualité et des capacités d'accueil adaptées dans les CT/CTE, particulièrement au Nord-Kivu.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.